

1 薬剤の分類マップ

細胞障害性抗がん薬

DNA合成・細胞分裂を障害

代謝拮抗薬 ゲムシタビン S-1 5-FU 微小管阻害薬 nab-パクリタキセル
白金製剤・トポI阻害薬 オキサリプラチン イリノテカン リポソーマルイリノテカン

分子標的薬・ICI

BRCA・NTRK・MSI-Highを標的

EGFR阻害薬(ゲムシタビン併用) エルロチニブ PARP阻害薬(gBRCA変異) オラパリブ
NTRK阻害薬(まれ) エヌトレクチニブ ラロトレクチニブ 抗PD-1抗体(MSI-High) ペムブロリズマブ

支持療法(治療の柱)

治療継続とQOLを支える

膵酵素補充 パンクレリパーゼ がん疼痛 オキシコドン フェンタニル貼付剤 鎮痛補助薬
発熱性好中球減少症の予防 ペグフィルグラスチム

☐ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 治療ラインの位置づけ(切除不能・遠隔転移)

対象	1次治療	2次治療	3次治療以降
全身状態良好 PS 0~1	modified FOLFIRINOX、またはゲムシタビン+nab-PTX	FOLFIRINOX後:ゲムシタビン+nab-PTX/Gem系後:リポソーマルイリノテカン+5-FU/LV、S-1	全身状態に応じて選択・緩和ケア中心
高齢・全身状態不良	ゲムシタビン単剤、S-1単剤	未使用の薬剤(S-1等)	緩和ケア中心
gBRCA変異陽性	プラチナを含む治療(FOLFIRINOX等)	(維持療法)16週以上増悪がなければオラパリブ	未使用の化学療法 等
MSI-High・NTRK融合遺伝子(まれ)	標準化学療法	ペムブロリズマブ/エヌトレクチニブ・ラロトレクチニブ	—

切除例の術後補助化学療法はS-1(6か月)が標準。切除可能境界例では術前化学療法も行われる。

3 副作用の特徴と発現時期

	投与日	1週	2週	3週	1か月	3か月～
● 早発性下痢・発汗(イリノテカン)	投与中～24時間					
● 発熱・倦怠感(ゲムシタビン)	当日～翌日					
● 悪心・嘔吐	～5日					
● 遅発性下痢(イリノテカン)	投与後数日～					
● 好中球減少(nadir)		7～14日目				
● 脱毛(nab-PTX)			2～3週で始まる			
● 貧血(オラパリブ)					開始1～3か月	
● 蓄積性末梢神経障害						累積投与量に依存

● 重篤・特に注意 ● その他

押さえておきたいポイント

- 全身状態で1次治療(FOLFIRINOX/GEM+nab-PTX)が分かれ、gBRCA変異ではオラパリブ維持療法も選択肢
- FOLFIRINOXは3系統の毒性が重なる。G-CSF予防・減量(modified)で継続性を確保する
- 膵酵素・疼痛・栄養・胆管炎の早期発見など、支持療法こそ薬局薬剤師が力を発揮する領域